

Trastornos Somatomorfos

Los **trastornos somatomorfos** agrupan una serie de patologías que comparten una característica fundamental: la presencia de síntomas físicos que sugieren una enfermedad médica, pero que no tienen una causa orgánica demostrable, sino que tienen un **origen psíquico**.

Generalidades de los Trastornos Somatomorfos

Estos cuadros clínicos suelen estar estrechamente vinculados al **estrés**. El paciente, ante una carga emocional o estresante significativa, "somatiza", desarrollando síntomas que simulan enfermedades orgánicas.

- **Complicaciones frecuentes:** Se asocian habitualmente a **Depresión** y **Trastornos Ansiosos**.
- **Diagnóstico:** Es eminentemente **clínico**.
- **Juicio de realidad:** Es fundamental entender que en estos trastornos **no hay psicosis**. El paciente puede tener miedo o sospecha de estar enfermo, pero no tiene la certeza absoluta e inamovible de un delirio.

NOTA CLÍNICA

Fisiopatología: La somatización es un mecanismo de defensa inconsciente donde el malestar psicológico se manifiesta a través de quejas físicas. El sistema nervioso autónomo y el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal suelen estar hiperactivados por el estrés crónico.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Importancia Médico-Legal: Siempre se deben solicitar exámenes básicos para descartar patología orgánica real. Diagnosticar un trastorno somatomorfo y pasar por alto un Accidente Vascular Encefálico (AVE) o un cáncer real conlleva responsabilidad médica.

Clasificación Clínica

1. Trastorno por Somatización

Es el cuadro más complejo y crónico. Se caracteriza por: - **Síntomas variados:** Dolor en múltiples sitios, síntomas gastrointestinales, genitourinarios, sexuales y neurológicos (vértigo, disestesias, visión borrosa). - **Cronicidad:** Los síntomas persisten por años y afectan significativamente la calidad de vida. - El dolor suele ser el síntoma predominante, pero nunca el único.

2. Trastorno por Dolor

A diferencia del anterior, aquí el **único síntoma es el dolor**. - Puede aparecer tras una lesión real (ej. fractura), pero el dolor persiste mucho más tiempo de lo esperado o con una intensidad que no se condice con el daño orgánico.

3. Hipocondría (Trastorno por Ansiedad por Enfermedad)

Lo central no es el síntoma en sí, sino el **miedo**. - **Clínica:** Síntomas escasos o inespecíficos (ej. una leve molestia abdominal). - **Conducta:** El paciente tiene un miedo persistente a tener una enfermedad grave (típicamente cáncer). - **Relación médico-paciente:** Suele ser difícil; el paciente desconfía de la capacidad diagnóstica del médico y exige constantemente exámenes de alta complejidad (como resonancias).

4. Trastorno Dismórfico Corporal

El paciente percibe una parte de su cuerpo como "horrible" o deforme, a pesar de ser normal o tener un defecto mínimo. - **Conductas de ocultamiento:** Uso de ropa holgada, pelo largo o gorros para tapar la zona "afectada". - **Cirugía Estética:** Es un error frecuente operar a estos pacientes. Suelen quedar disconformes y el riesgo de demanda judicial es muy alto. El tratamiento es salud mental, no el bisturí.

Trastornos por Falsificación de Síntomas

Existe un grupo donde el paciente **finje o se autoinduce** los síntomas. La diferencia radica en la ganancia buscada:

TABLA 7.23.1: CARACTERÍSTICA VS TRASTORNO FACTICIO		
CARACTERÍSTICA	TRASTORNO FACTICIO	SIMULACIÓN
Mecanismo	Fingir o autoinducir síntomas.	Fingir o autoinducir síntomas.
Ganancia	Primaria/Afectiva: Cuidados, atención, afecto, rol de enfermo.	Secundaria/Económica: Dinero, indemnizaciones, evitar la cárcel, licencias.
Ejemplo clásico	Síndrome de Munchausen (o por poder si es a un hijo).	Reo que finje locura para no ser procesado.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Perla EUNACOM: Si el caso clínico menciona a una madre que enferma a su hijo para recibir atención del equipo médico, marca **Trastorno Facticio por Poder**. Si un paciente se inyecta insulina para provocar hipoglicemias y ganar atención, es un **Síndrome de Munchausen**.

Diagnóstico Diferencial: ¿Cómo distinguirlos?

Para el examen, es vital diferenciar estos cuadros de otras patologías psiquiátricas:

TABLA 7.23.2: CASO CLÍNICO VS SOSPECHA DIAGNÓSTICA		
CASO CLÍNICO	SOSPECHA DIAGNÓSTICA	CLAVE DEL DIAGNÓSTICO
Dolor tras fractura que persiste 6 meses sin causa ósea.	Trastorno por Dolor	Síntoma único de dolor desproporcionado.
Paciente que cree que sus dientes son deformes (estando normales) y pide cirugía.	Trastorno Dismórfico	Enfoque en un defecto físico inexistente.
Paciente con múltiples síntomas (cefalea, diarrea, hormigueo) sin causa orgánica.	Trastorno por Somatización	Pluralidad y variedad de síntomas.
Paciente exige resonancia por un dolor leve, temiendo un tumor cerebral.	Hipocondría	Miedo a enfermedad grave + exigencia de exámenes.
Paciente asegura tener cáncer de tiroides pese a eco y TSH normales (Certeza absoluta).	Delirio de Enfermedad	Pérdida de juicio de realidad (es psicótico, no somatomorfo).
Paciente reza compulsivamente para que no le dé cáncer.	Trastorno Obsesivo Compulsivo	Presencia de compulsiones para calmar la ansiedad.
Paciente dice que no camina por accidente, pero lo ven jugando fútbol tras demandar a la empresa.	Simulación	Ganancia económica evidente (indemnización).

Manejo General

- **Educación y Tranquilización:** Explicar que los síntomas son reales (el paciente siente el dolor), pero que su origen es el estrés y no un daño en los órganos.

- **Psicoterapia:** Es el pilar del tratamiento.
- **Fármacos:** No se usan de forma primaria para el trastorno somatomorfo. Solo se indican si hay comorbilidad con **Depresión** o crisis de pánico.
- **Derivación:** En casos de hipocondría grave o trastorno dismórfico, la evaluación por salud mental es obligatoria antes de cualquier intervención invasiva.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Mujer de 45 años consulta por múltiples síntomas: cefalea, dolor abdominal, hormigueos en las manos, dificultad para tragar y dismenorrea intensa. Los exámenes son normales. Lleva años con este cuadro. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Trastornos Somatomorfos. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Somatización: múltiples síntomas variados crónicos; hipocondría: pocos síntomas con gran miedo a enfermedad grave; trastorno por dolor: solo dolor.
- El TDC (trastorno dismórfico corporal) considera horrible una parte del cuerpo; no operar sin evaluación de salud mental previa.
- Trastorno facticio: finge síntomas para obtener afecto y cuidados (no dinero); síndrome de Munchausen es la forma grave.
- Trastorno por simulación: finge síntomas para obtener ganancia económica o evitar consecuencias legales.
- Todos los trastornos somatomorfos requieren descartar causa orgánica con exámenes antes de atribuirlos a causa psíquica.
- El tratamiento es psicoeducación + psicoterapia; no requieren fármacos salvo que se compliquen con depresión.
- La hipocondría en que el paciente **ASEGURA** tener cáncer a pesar de exámenes normales orienta a delirio de enfermedad (psicosis), no a hipocondría.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (TRASTORNOS SOMATOMORFOS)

PREGUNTA 1

Mujer de 45 años consulta por múltiples síntomas: cefalea, dolor abdominal, hormigueos en las manos, dificultad para tragar y dismenorrea intensa. Los exámenes son normales. Lleva años con este cuadro. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- ☐ A) Trastorno por dolor; psicoterapia
- ☐ B) Hipocondría; psicoterapia
- ☐ C) Trastorno de somatización; descartar causa orgánica + psicoterapia
- ☐ D) Trastorno facticio; derivar a psiquiatría
- ☐ E) Depresión mayor con somatización

PREGUNTA 2

Hombre de 30 años consulta reiteradamente por molestia epigástrica leve. Se realizó endoscopia que fue normal. Ahora exige una resonancia magnética porque cree que tiene cáncer gástrico. Refiere que "los médicos no le hacen los exámenes correctos". ¿Cuál es el diagnóstico?

- ☐ A) Trastorno de somatización
- ☐ B) Hipocondría; psicoterapia y no ceder a exámenes innecesarios
- ☐ C) Trastorno delirante con delirio de enfermedad
- ☐ D) Simulación; derivar a instancias legales
- ☐ E) Trastorno facticio; psicoterapia urgente

PREGUNTA 3

Hombre de 35 años fue atropellado 6 meses atrás. Dice que no puede caminar ni trabajar debido al accidente y ha demandado al conductor por una indemnización millonaria. Sus vecinos lo han visto jugando fútbol en la cancha del barrio. ¿Cuál es el diagnóstico?

- ☐ A) Trastorno por dolor somatomorfo
- ☐ B) Trastorno facticio
- ☐ C) Trastorno por simulación
- ☐ D) Trastorno conversivo
- ☐ E) Hipocondría con parálisis histérica

RESUMEN: TRASTORNOS SOMATOMORFOS

Los trastornos somatomorfos se caracterizan por síntomas físicos (somáticos) sin causa orgánica que los explique completamente, de causa psíquica (generalmente estrés). No hay pérdida del juicio de realidad. El diagnóstico es clínico y siempre requiere descartar causa orgánica con los exámenes pertinentes (por responsabilidad médico-legal). El tratamiento es psicoeducación + psicoterapia cognitivo-conductual; no requieren fármacos a menos que se compliquen con depresión u otro trastorno. Todos pueden complicarse con depresión. El trastorno de somatización tiene múltiples síntomas variados de distinto tipo (dolor, síntomas gastrointestinales, genitourinarios, neurológicos, etc.) de curso crónico. El trastorno por dolor tiene un único síntoma: dolor, que persiste más allá de lo esperable para la causa orgánica subyacente. La hipocondría tiene pocos síntomas con gran preocupación por tener una enfermedad grave (habitualmente cáncer); el paciente desconfía del médico y exige exámenes. El trastorno dismórfico corporal (TDC) considera horrible una parte específica del cuerpo y busca cirugía estética; se asocia a mayor riesgo de demanda médica. El trastorno facticio finge o se autoinduce síntomas buscando afecto y cuidados (no dinero); el síndrome de Munchausen es la forma más grave de autoinducción; el Munchausen por poder implica enfermar a otro (habitualmente madre-hijo). El trastorno por simulación finge síntomas con ganancia económica (pensión de invalidez, indemnización, evitar la cárcel). La diferencia entre facticio y simulación es el tipo de ganancia: afecto vs dinero.